

Ciudad Autónoma de Bs As, octubre de 20[REDACTED]

TRIBUNAL: JUZGADO CIVIL [REDACTED]

DIRECCIÓN: URUGUAY 714 PISO [REDACTED] C.A.B.A

PERITO PSICÓLOGA PRESENTA INFORME PERICIAL

SEÑOR JUEZ:

[REDACTED], Matrícula N° [REDACTED], Perito Psicóloga, constituyendo domicilio legal en Zabala [REDACTED] CP 1426 C.A.B.A, en los autos caratulados **“RODRIGUEZ, [REDACTED] c/ [REDACTED] SA Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)”** EXP N° [REDACTED]/2018 se presenta respetuosamente a V.S. y expresa:

Que en cumplimiento de lo ordenado, y habiendo realizado el estudio requerido, vengo a presentar en tiempo y forma el resultado del Informe Pericial Psicológico de la **Sra. [REDACTED]** (DNI [REDACTED]) a los fines de que el perito médico legista conteste los puntos de pericia.

Que el mismo informe consta de los siguientes apartados, a saber:

- I. DATOS PERSONALES DE LA ACTORA.
- II. PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PERICIA.
- III. RESEÑA HISTOBIOGRAFICA REFERIDA POR EL PERITADO.
- IV. ANALISIS INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA Y DE LAS TECNICAS IMPLEMENTADAS.
- V. CONCLUSIONES
- VI. PETITORIO.

I. DATOS PERSONALES DE LA ACTORA:

Nombre y Apellido: [REDACTED]

Fecha y lugar de nacimiento: 24.01.1955

Edad: 64 años

Documento de identidad: [REDACTED]

Estado Civil: divorciada

Escolaridad: Secundario Incompleto

Ocupación actual: Desocupada.

Grupo familiar conviviente: Vive con su pareja Miguel Ángel Flores.

Grupo familiar de origen:

Padre: Nacionalidad Argentina, 85 años. Jubilado.

Madre: Nacionalidad Argentina, 81 años. Jubilada.

Hermano (paterno): [REDACTED], 56 años, albañil.

Hermana (materna): [REDACTED], 54 años, empleada de limpieza.

Hermana (materna): [REDACTED], 45 años, se desconoce su ocupación.

Hermano (materno): [REDACTED], 49 años, empleado de seguridad.

Hermana (materna): [REDACTED], 36 años, ama de casa.

II. PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PERICIA:

- Entrevista clínica semidirigida
- Técnicas gráficas: Test Gestaltico Visomotor (Test de Bender)
- HTP (Test Casa- Arbol- Persona)

- Test de Rorschach.

Cabe aclarar que la selección de la batería de técnicas implementada fue realizada en base a decisiones clínicas y respecto de los puntos de pericia a responder. Se trabajó luego analizando, clínica y semiológicamente a la actora, así como luego corroborando y analizando los resultados de las diversas técnicas, desde las recurrencias y convergencias, inter e intratests, llegando así a conclusiones diagnósticas y pronósticas provistas por la evaluación global de la examinada.

A su vez, se debe destacar que la examinada concurrió a todas las entrevistas en el día y horario previsto, habiéndose demostrado colaboradora durante la entrevista semidirigida, aunque con desgano y falta de energía durante la toma de técnicas.

Las técnicas fueron administradas durante los encuentros pautados los días 24 de septiembre y 1° de octubre de 20 [REDACTED]

III RESEÑA HISTOBIOGRAFICA REFERIDA POR LA ACTORA

Antecedentes personales y heredo-familiares

Según sus dichos la Sra. [REDACTED] proviene de un grupo familiar primario conformado por sus padres y abuelos. Nació en [REDACTED] (Misiones) en 1955. Contó que se crió allí junto a sus abuelos, ya que sus padres debieron salir a trabajar. A sus 7 años, sus padres se separaron. Ambos formaron nuevas parejas y tuvieron hijos, por lo que la Sra. [REDACTED] tiene 5 hermanos a quienes conoció siendo adulta.

En Misiones terminó el colegio primario y a sus 11 años vino a vivir a Buenos Aires junto a sus abuelos, donde realizó el colegio secundario sin finalizarlo, dado que comenzó a trabajar y realizar ambas actividades le generaba mucho estrés.

Respecto a sus vínculos de amistad, comenta no haber profundizado en los mismos pero haber tenido buena relación con sus ex compañeros/as del colegio.

Con respecto a su juventud, cuando sus abuelos fallecieron, la Sra. [REDACTED] comenzó a trabajar como niñera y dormía en esa casa durante los días de semana. Los fines de semana vivía en lo de su tía. Luego realizó un curso de corte y confección, trabajó en ese rubro y en una Delegación Municipal durante 12 años. Al momento del accidente, trabajaba en dos talleres de costura y en su casa como modista.

Respecto a sus relaciones de pareja, la Sra. [REDACTED] relata que se casó a sus 20 años con quien era su amigo, recibiendo presión por parte de su familia para que lo hiciera. Tuvieron 3 hijos (de 38, 37 y 24 años actualmente) y luego de 24 años se separaron. Tienen 4 nietos.

Además, cuenta que actualmente está en pareja con [REDACTED], a quien conoció en un viaje en auto hace 3 años, ya que él trabaja de remisero.

Comenta que al día de hoy, tiene buena relación tanto con sus padres, aunque estos viven aún en Misiones, como con su actual pareja y sus hijos.

Al presente la actora se encuentra sin trabajo debido a su condición física generada por el hecho de autos.

Relato del hecho de autos

Martha relata que el día 22 de febrero de 2015 viajaba dirigiéndose al dentista en el colectivo de la línea [REDACTED], en la localidad de [REDACTED] (partido de La Matanza), cuando, al momento de bajarse de la unidad, y antes de finalizar su descenso, el chofer, arranca sorpresivamente provocando así que la actora se caiga al asfalto. Cuenta que una persona de género masculino – no tiene datos sobre la persona- la ayudó a levantarse y la trasladó al Policlínico San Justo, donde no había médicos disponibles, por lo que se volvió a su casa en colectivo de la línea [REDACTED]. Al momento de bajarse, no lograba descender debido al dolor en su pierna derecha y espalda, por lo que un vecino suyo llamado [REDACTED], la asistió para poder descender y la transportó más tarde al Hospital Interzonal de Agudos Profesor Dr. Luis Güemes de Haedo. Allí le hicieron dos placas y luego la enyesaron. Utilizó ese yeso durante 3 meses.

Cuenta la Sra. [REDACTED] que, luego de retirado el yeso, comenzó a utilizar muletas durante casi un año. Los médicos le indicaron una cirugía, la cual fue postergada reiteradas veces debido a los paros del mismo hospital.

Finalmente acudió a la Clínica [REDACTED] y la operaron allí, aproximadamente un año luego de ocurrido el accidente (25/02/2017). A partir de ese momento utilizó bastón durante un largo tiempo y le indicaron aproximadamente 90 sesiones de kinesiología.

Otros datos relevantes:

Desde el mismo día en el que ocurrió el accidente, la Sra. [REDACTED] se vio inhabilitada a trabajar debido a su condición física. Cuenta que, al estar mucho tiempo sentada, comienza a sentir un dolor intenso en la rodilla y en la cadera. Esto no sólo le generó una pérdida económica desde el aspecto laboral sino también un cambio en su estado anímico: *“Yo siempre fui muy activa, el accidente me cambió todo. Me afectó el ánimo. Caí en una depresión. Me sentía inútil, porque necesitaba ayuda para todo. Me tenían que ayudar a bañarme. Me daba vergüenza, me*

sentía devastada, y aparte de eso, el dolor físico. Me cortó al medio. Lloraba, me encerraba en mi misma. No quería comer. Fue de un día para el otro. Ahora no se supera, se sobrelleva” (sic).

Relata que una enfermera particular que se acercaba diariamente a tomarle la presión, le recetó alprazolam para poder dormir.

Se puede afirmar entonces que [REDACTED] sufrió disminución del apetito e insomnio de conciliación a partir del accidente como secuela de un hecho traumático. Además, manifiesta necesitar de un tercero para su higiene personal.

Respecto al lucro cesante, comenta que, al no poder trabajar, debe mantenerse únicamente con el pago de su jubilación, la cual es utilizada en gran porcentaje para la compra de medicamentos. Esto implica, además, que la actora no realice ningún tipo de actividad durante su jornada diaria.

La Sra. [REDACTED] comenta: “*Mi vida ahora es pasiva. Antes salía a correr, tenía varios trabajos. Ahora mi esposo y mi hija mayor me cuidan mucho*”. (sic)

Actualmente toma la siguiente medicación: Alprazolam, Losartan y Carvedilol.

IV. ANALISIS INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA Y DE LAS TECNICAS IMPLEMENTADAS.

A partir del análisis del proceso psicodiagnóstico, puede decirse que [REDACTED] es una mujer vestida acorde a edad, sexo, nivel sociocultural y época del año, la cual se presenta prolija a cada uno de los encuentros. Hipobúlica, eumnésica, euproséxica, globalmente orientada, lúcida, con el juicio conservado, que mantiene idea directriz, sin trastornos en la articulación de la palabra, distímica, colaboradora. Sin agresividad ni impulsividad latente o manifiesta.

La actora es una persona capaz de captar la realidad con eficacia del mundo que la rodea, con una baja capacidad de insight, pobreza ideativa, con poca creatividad y flexibilidad y/o observándose fallas en la simbolización y en la integración de sus emociones.

Se encuentra acentuado el funcionamiento de la disociación y la evitación como mecanismos de defensa primordial, ya que se evidencia una evitación emocional y una sobresimplificación de los hechos para que las emociones que estos le producen no la invadan. (*Test de Rorschach: F% levemente aumentado, Prop C% disminuido*)

Se ubican ciertos rasgos depresivos, hay una reducción de energía psíquica (*Test de Rorschach: poca respuesta M*), así como incapacidad para acercarse a sus fantasías y falta de fuerza asociativa y de producción. Se refleja poca capacidad creadora, en este caso por angustia difusa, profunda y regresiva (*respuesta “agua” en Test de Rorschach*).

Se infiere también un mal pronóstico terapéutico (*estupor en la última lámina del Test de Rorschach*).

Se evidencia también formación reactiva (*fenómeno especial: respuesta diminutivo*), fragilidad (*respuesta “cristal”*), minusvalía (*respuesta “adornos”*), índices de tipo traumático (*respuesta Siniestro*) y tensión ideacional sentida como externa (*respuesta Fm*).

A través del Test de Bender se pudo evidenciar falta de capacidad de planificación, gráficos sin puntos de contacto; esto se relaciona con su mundo interno. Se la ve como una persona madura pero con alteraciones desde el punto de vista emocional, hay índices de aislamiento y de conflicto, así como problemas interpersonales.

Además, es importante tener en cuenta la etapa vital de la actora ya que se encuentra con mayores dificultades para rearmar un proyecto laboral.

Se puede concluir que el hecho de autos provocó el perjuicio en diversas áreas vitales de la actora: autonomía, autoestima, autorrealización y económica.

Se descartan indicadores de simulación, organicidad y alteraciones sensoperceptivas.

V. CONCLUSIONES.

Teniendo en cuenta que al hacer un diagnóstico lo hacemos en función de un sujeto, el cual debe considerarse como una integridad biopsicosocial; valorando entonces el conjunto del ser, y considerando que el término “daño psíquico” corresponde a una construcción del discurso jurídico, encontrando su correlato en el discurso psiquiátrico-psicológico bajo la denominación de “Trastorno Adaptivo Mixto, con Ansiedad y Estado de Ánimo Depresivo” (F43.22 - DSM IV).

En su libro *El daño en Psicopsiquiatría Forense*, el Dr. Mariano Castex, expresa claramente que: “El daño psíquico se constituye en reacción a una injuria, traumatismo o noxa con entidad suficiente para causar una lesión que eventualmente deja secuela cronicada”.

En consecuencia se ha definido como daño psíquico toda forma deterioro o detrimento o disfunción o disturbio o alteración o desarrollo psicogénico o psicoorgánico o trastorno o perturbación que impactando sobre las esferas afectiva y/o intelectual y/o volitiva de un determinado individuo, limita su capacidad de goce individual, laboral, social y o recreativa.

En el caso de la actora, las afecciones físicas que sufre, le han provocado una disminución de su capacidad de goce individual, familiar, social, laboral y recreativo, condicionando su vida, empobreciéndola.

Estas repercusiones en el plano psicológico, se expresan a través de los test mostrando un yo con recursos bajos, un psiquismo donde la prueba de realidad y el juicio lógico se encuentran conservados, o sea una personalidad de base neurótica, pero en la que a su vez se detectan signos de angustia y ansiedad.

En conclusión, la peritada presenta un “Trastorno Adaptivo Mixto, con Ansiedad y Estado de Ánimo Depresivo” (F43.22 - DSM IV) asimilable a Desarrollo Reactivo Moderado, con incapacidad del 20.00% (veinte por ciento), en una relación de causalidad directa con las afecciones físicas que padece.

Se determina conveniente la realización de tratamiento psicoterapéutico en la actualidad para la actora, debido a su cuadro clínico actual.

Si bien suele ser difícil establecer la duración del mismo, ya que depende de la reacción de cada sujeto, se puede estimar que el mismo deberá tener una extensión no menor a un año.

La frecuencia de sesiones quedará bajo criterio del/a profesional actuante, aunque se estima como conveniente una frecuencia de una vez por semana, sugiriendo una psicoterapia de frecuencia semanal, incluyendo algún tipo de labor-terapia. El costo promedio de una sesión de psicoterapia individual en el ámbito privado se estima en \$900.

IV. PETITORIO:

Con lo anteriormente expuesto, se considera que es todo cuanto puedo informar a V.S., por ello, solicito:

- 1- Se dé por cumplida la tarea pericial encomendada y presentado, en tiempo y forma, el dictamen pericial.
- 2- Se confiera traslado a las partes.
- 3- Se regulen oportunamente mis honorarios profesionales.

Proveer de conformidad que

SERÁ JUSTICIA